VS AVNRT:房室结折返的心动过速

（3）预激综合征伴顺向型房室折返性心动过速 AVRT

①刺激迷走神经终止发作：按摩 ttsx 一侧颈动脉窦、Valsalva、刺激咽诱导恶心（消化道有很多迷走神经）、面部浸于冰水

②无效首选腺苷，次选维拉帕米、地尔硫卓等（β-R拮抗剂、胺碘酮）；但**禁用强心苷**（缩短旁路不应期-水火不相容）

③伴血流动力学障碍用电复律（血压低我电击）

一般规律

《药理学》《生理学》:对于AVNRT或AVRT维拉帕米、地尔硫卓相比β-R拮抗剂更好
①维拉帕米、地尔硫卓对于房室结的抑制更加专一
①维拉帕米、地尔硫卓搞的就是L型慢钙通道,房室结是慢反应细胞

《生理学》：右侧迷走神经主要支配窦房结→心率减慢为主；左侧迷走神经主要支配房室交界→房室传导减慢为主（迷走神经对心室肌支配很少）

所以按左侧颈动脉窦会更好

《生理学》：Valsalva 瓦尔萨瓦动作（拉粑粑）：深吸气、再紧闭声门用力呼气→胸腔负压可变为正值→回心血量明显↓→前负荷↓→搏出量↓→动脉血压↓→经窦弓反射兴奋交感神经。随后，紧闭的声门突然松开→回心血量明显↑→搏出量↑→动脉血压↑→经窦弓反射兴奋迷走神经，这就是 Valsalva 的目的

2.心电生理检查最佳 VS心律失常首选心电图

xian B B 点 心

房室折返的心动过速不要用强心苷

3.心电图（小倒大粗）治疗:迷走神经、β-R拮抗剂、腺苷、IV(非CCB)、胺碘酮、强心苷　预激和强心苷水火不相容

①**PR 间期＜0.12s**

②**QRS 波宽大畸形**（但顺向型房室折返性心动过速 QRS 波形态多**正常**）

③QRS 波起始部**粗钝（δ 波）**小坡坡

④ST-T 波呈继发性改变（T 波与 QRS 主波方向相反——**T 波倒置**）



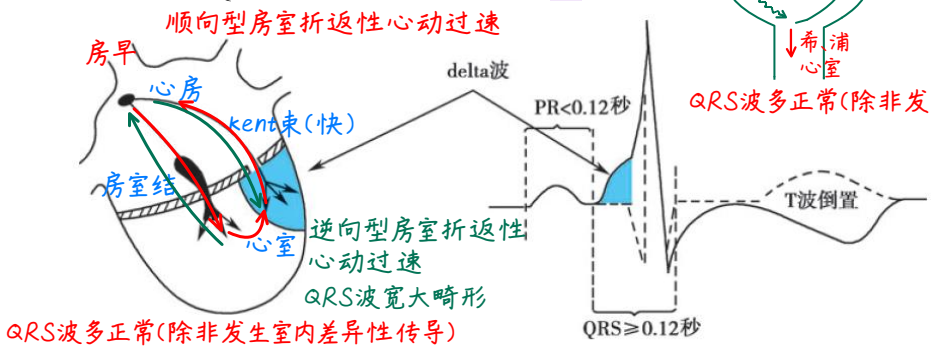


图 5-1-94　WPW 综合征特殊的心电图特征

